

Case 1:

Karl, 72 år, har känd KOL GOLD 3. Flera tidigare inläggningar för exacerbationer. Rökt i 45 år, slutade för 5 år sedan. Bor hemma med sin fru. Har senaste veckan varit förkyld och haft ökad slemproduktion. Söker nu pga tilltagande andfåddhet och trötthet.

Aktuellt: Patienten upplevs trött och orkar knappt tala i hela meningar. Sitter framåtlutad i sängen. Har fått syrgas 2 L/min på näsgrimpa av ambulansen.

Vitalparametrar: Andningsfrekvens: 26/min, Saturation: 89 % (med 2 L O₂), Puls: 104/min, Blodtryck: 148/86 mmHg, Temp: 37,8 °C, Medvetandegrad: Somnolent men väckbar (RLS 2)

Blodgas: pH: 7,28, pCO₂: 8,2, kPa pO₂: 7,4, kPa, HCO₃⁻: 30 mmol/L, BE: +4

Övriga fynd: Rikligt med segt slem. Förlängt expirium. Använder accessorisk andningsmuskulatur

Diskussionsfrågor:

Vilken syra-basrubbing föreligger?

Är tillståndet akut, kroniskt eller akut på kroniskt?

Hur förklaras blodgasbilden utifrån anamnesen?

Vilka omvårdnadsprioriteringar är viktigast första 30 minuterna?

Vilka försämringstecken måste rapporteras omedelbart?

Case 2:

Sara, 17 år, tidigare frisk kommer in till akutmottagningen tillsammans med sina föräldrar. Har haft illamående, kräkningar och buksmärta i två dygn. Har

inte kunnat behålla mat eller vätska. Under senaste månaderna succesivt tappat i vikt.

Aktuellt: Patienten är blek, torr i munnen och luktar aceton. Hon är vaken men orolig, har svårt att hålla ordning på samtalet och upprepar sig ofta. Klagar över kraftig törst.

Vitalparametrar: Andningsfrekvens: 30/min (djup, suckande andning)
Saturation: 98 % på luft Puls: 118/min Blodtryck: 96/60 mmHg Temp: 36,7 °C
Medvetandegrad: C

Blodgas: pH: 7,11 pCO₂: 3,2 kPa pO₂: 13,0 kPa HCO₃⁻: 9 mmol/L BE: -16

Övrigt: P-glukos: 28 mmol/L Ketonar i blod: kraftigt förhöjda Minskat urinflöde

Diskussionsfrågor:

Vilken typ av syra-basrubbing föreligger?

Hur speglar andningsmönstret blodgasen?

Vilka fynd talar för ett allvarligt tillstånd?

Vilka omvårdnadsåtgärder måste initieras omedelbart?

Vad behöver följas tätt under första timmarna?

Case 3

Bakgrund / anamnes:

Erik, 68 år, har hypertoni och typ 2-diabetes. Bor hemma med sin fru. Har haft feber, hosta och tilltagande trötthet i tre dygn. Enligt hustrun har han varit mer förvirrad senaste dygnet och knappt velat dricka.

Aktuellt:

Blek hud och kall perifert. Svarar långsamt på tilltal, verkar desorienterad och har svårt att fokusera blicken. Klagar över frossa och andfåddhet. Huden är torr, kapillär återfyllnad > 4 sek.

Vitalparametrar:

Andningsfrekvens: 28/min, Saturation: 92 % på 4 L O₂, Puls: 116/min, Blodtryck: 88/54 mmHg, Temp: 39,2 °C, Medvetandegrad: RLS 2 (slö, väckbar)

Blodgas:

pH: 7,26, pCO₂: 4,0 kPa, pO₂: 8,5 kPa, HCO₃⁻: 16 mmol/L, BE: -10

Övrigt:

Laktat: 5,2 mmol/L CRP: 210 mg/L Urinproduktion: mycket sparsam senaste 12 timmarna. Misstänkt pneumoni på lungröntgen

Diskussionsfrågor

1. Vilken syra-basrubbing föreligger?
2. Vad i blodgasen tyder på att detta är ett allvarligt tillstånd?
3. Hur hänger patientens andningsmönster ihop med acidosen?
4. Vilka omvårdnadsåtgärder måste initieras omedelbart?
5. Vilka parametrar behöver följas tätt de närmaste timmarna?
6. Vad är den största risken om tillståndet inte behandlas snabbt?